



Programa de Formación: Psicología Aplicada a la Tarea Pastoral

Este programa híbrido capacita a los líderes en la detección temprana, contención inicial y derivación responsable de problemáticas de salud mental, utilizando herramientas con evidencia científica.

Duración: 8 semanas (4 módulos virtuales + 4 encuentros presenciales).

Enfoques: Terapia Cognitivo Conductual (TCC), Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y Habilidades de Comunicación.

Este proyecto de formación integral tiene como objetivo equipar a líderes y pastores con herramientas psicológicas basadas en la evidencia para fortalecer el cuidado pastoral, estableciendo límites claros con la psicoterapia clínica y promoviendo la salud mental dentro de la comunidad de fe. A continuación, se detallan los ejes temáticos esenciales de la capacitación:

1. Marco Ético y Límites de Intervención

El programa establece una distinción fundamental entre el consejo pastoral y la psicoterapia. Mientras que el primero se centra en el acompañamiento espiritual y crisis vitales normativas utilizando recursos como la oración y los textos sagrados, la psicoterapia es una intervención científica para trastornos mentales. Se enfatiza la competencia de derivación, capacitando al líder para reconocer indicadores de riesgo (como ideación suicida o trastornos psicóticos) que requieren atención profesional inmediata.

2. Modelos Psicológicos Aplicados a la Consejería

La formación integra herramientas de dos corrientes principales:

Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC): Utiliza el modelo ABCDE para ayudar a las personas a identificar cómo sus creencias irracionales (exigencias rígidas como "debo" o "tengo que") distorsionan la realidad y aumentan el sufrimiento.

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Se enfoca en desarrollar flexibilidad psicológica. En lugar de evitar el dolor (evitación experiencial), se promueve la aceptación del malestar inevitable mientras se actúa de acuerdo con valores personales significativos.

3. Herramientas de Evaluación y Cambio Cognitivo

Se enseñan técnicas específicas para profundizar en el mundo interno del aconsejado:

Técnica de la Flecha Descendente: Permite ir más allá de los pensamientos automáticos para identificar creencias nucleares profundas (ej. "no soy valioso") que sostienen el malestar espiritual y emocional.

Identificación de Distorsiones Cognitivas: Entrenamiento para detectar sesgos como el pensamiento dicotómico ("todo o nada") o la sobregeneralización, facilitando una interpretación de la realidad más equilibrada y realista.

Defusión Cognitiva: Ejercicios para que el líder y el aconsejado aprendan a observar sus pensamientos como eventos mentales transitorios y no como verdades absolutas, reduciendo su impacto sobre la conducta.

4. Comunicación Asertiva y Liderazgo

El proyecto aborda la comunicación como una expresión de madurez emocional. Se diferencia el estilo asertivo de los patrones pasivos o agresivos, proporcionando un guion de cuatro pasos (Hechos, Sentimientos, Pedidos y Consecuencias) para resolver conflictos ministeriales con claridad y respeto. Asimismo, se introduce el Método Socrático, basado en el diálogo reflexivo mediante preguntas que fomentan el discernimiento y la responsabilidad personal en lugar de imponer respuestas.

5. Gestión de Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

Se capacita en protocolos de intervención temprana para situaciones de alto impacto:

Protocolo ABCDE de los PAP: Pasos secuenciales de Escucha Activa, Reentrenamiento de la Ventilación (respiración), Categorización de necesidades, Psicoeducación y Derivación.

Planes de Seguridad: Diseño de estrategias de protección para la prevención del riesgo suicida y para situaciones de violencia interpersonal, priorizando siempre la integridad física y la reducción de la carga cognitiva durante la crisis.

6. Autocuidado y Prevención del Burnout

Reconociendo que el liderazgo es una labor de alto desgaste, la formación incluye un módulo sobre el síndrome de burnout. Se brindan herramientas de monitoreo como el "termómetro del desgaste" y metáforas de autocuidado (ej. "El Huerto Olvidado" o "El Filtro del Agua") para ayudar al líder a establecer límites saludables, delegar responsabilidades y mantener su propia salud emocional y espiritual a largo plazo.

Plan de encuentros presenciales a desarrollarse en el espacio físico de Dignos. (Sábados de 8 a 12)

ENCUENTRO 1

Laboratorio de Escucha Activa y Triage Pastoral

Ejercicio 1: Escucha Activa en Situaciones de Crisis

Fundamentación Académica

La evidencia científica muestra que las personas en crisis suelen beneficiarse más de una escucha empática y validante que de soluciones rápidas o interpretaciones prematuras. La escucha activa constituye una habilidad central en modelos de intervención en crisis, consejería pastoral y psicoterapia basada en la evidencia.

Objetivos

Al finalizar el ejercicio, los participantes serán capaces de:

Aplicar técnicas básicas de escucha activa.

Diferenciar escucha de asesoramiento.

Utilizar reflejo emocional y paráfrasis.

Incrementar la sensación de contención emocional del interlocutor.

Competencias a desarrollar

Empatía clínica.

Atención plena interpersonal.

Comunicación asertiva.

Contención emocional inicial.

Procedimiento

Fase 1: Preparación (10 minutos)

El docente distribuye tarjetas con casos ficticios.

Caso A: Duelo

"Mi esposa falleció hace tres meses. Todos esperan que ya esté mejor, pero siento que cada día es más difícil."

Caso B: Pérdida Laboral

"Me despidieron después de veinte años. Siento que soy un fracaso."

Caso C: Crisis de Fe

"Le pedí a Dios durante meses que sanara a mi hijo y nada cambió. No sé si puedo seguir creyendo."

Fase 2: Role Playing (7 minutos)

Alumno A

Actúa como feligrés.

Debe:

Expresar emociones genuinas.

Relatar la situación.

Mostrar preocupación y angustia.



Alumno B

Actúa como pastor consejero.

Solo puede utilizar:

Preguntas abiertas.

Paráfrasis.

Reflejo emocional.

Resúmenes breves.

No puede:

Dar consejos.

Citar versículos automáticamente.

Minimizar el dolor.

Intentar resolver el problema.

Ejemplos de respuestas adecuadas

Feligrés:

"Siento que fracasé."

Pastor:

"Lo que escucho es que perder tu trabajo ha afectado profundamente la manera en que te ves a vos mismo."

Feligrés:

"Dios me abandonó."

Pastor:

"Parece que estás experimentando una profunda sensación de soledad y desilusión espiritual."

Fase 3: Evaluación del Receptor (5 minutos)

El feligrés califica de 1 a 10:

Me sentí escuchado.



Me sentí comprendido.

Me sentí respetado.

Me sentí contenido.

Debriefing

Preguntas grupales:

¿Qué fue difícil al no dar consejos?

¿Qué produjo mayor sensación de contención?

¿Qué errores aparecieron con más frecuencia?

ENCUENTRO 2

Debate de Pensamientos y Reestructuración Cognitiva

Ejercicio: Desmantelamiento de Creencias Irracionales

Fundamentación Académica

Basado en la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) de Albert Ellis.

Las emociones disfuncionales suelen estar influenciadas por interpretaciones rígidas y absolutistas más que por los hechos en sí mismos.

Objetivos

Los participantes aprenderán a:

Identificar pensamientos irracionales.

Diferenciar hechos e interpretaciones.

Aplicar el modelo ABC de la TREC.

Construir alternativas cognitivas más flexibles.

Material de trabajo

Carta 1

"Dios me está castigando por mis errores pasados."



Carta 2

"Si mis hijos se alejaron de la iglesia, significa que fracasé como padre."

Carta 3

"Como líder debería poder soportar todo sin sentirme agotado."

Procedimiento

Paso 1: Identificar el ABC

A (Acontecimiento)

¿Qué ocurrió realmente?

B (Creencia)

¿Qué interpretación hizo la persona?

C (Consecuencia)

¿Qué emociones aparecen?

Ejemplo

A: Perdí mi empleo.

B: "Soy inútil."

C: Desesperanza y vergüenza.

Paso 2: Debate Cognitivo

Preguntas socráticas

¿Cuál es la evidencia objetiva?

¿Existe otra explicación posible?

¿Qué le dirías a otra persona en esta situación?

¿La conclusión es lógica o extrema?

Paso 3: Reformulación

Creencia original:

"Dios me está castigando."

Nueva formulación:

"Estoy atravesando una situación dolorosa y estoy interpretándola como castigo, aunque existen otras explicaciones posibles."

Debriefing

¿Qué diferencia encontraron entre hecho e interpretación?

¿Qué emociones cambiaron después de la reformulación?

ENCUENTRO 3

Taller de Mindfulness y Defusión Cognitiva

Ejercicio: Hojas en el Río Aplicado a la Culpa

Fundamentación Académica

Basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) desarrollada por Steven C. Hayes.

La defusión cognitiva busca modificar la relación con los pensamientos en lugar de discutir permanentemente su contenido.

Objetivos

Identificar pensamientos automáticos de culpa.

Practicar observación consciente.

Reducir fusión cognitiva.

Reconectar con valores ministeriales.

Procedimiento

Fase 1: Centramiento (3 minutos)

El facilitador guía una breve práctica atencional.

"Observe su respiración sin intentar modificarla."

Fase 2: Visualización (10 minutos)



Lectura guiada:

"Imagine un río tranquilo. Sobre la superficie flotan hojas que son transportadas por la corriente."

"Ahora identifique un pensamiento de culpa frecuente."

Ejemplos:

"No soy un buen pastor."

"Debería haber hecho más."

"He decepcionado a Dios."

Fase 3: Defusión

El participante coloca cada pensamiento sobre una hoja imaginaria.

No debe:

Combatirlo.

Justificarlo.

Analizarlo.

Solo observarlo alejarse.

Fase 4: Reconexión con Valores

Preguntas de reflexión:

¿Qué clase de líder deseo ser?

¿Qué valores quiero encarnar?

¿Qué acción pequeña puedo realizar esta semana?

Ejercicio Complementario

"Estoy teniendo el pensamiento de..."

Pensamiento:

"He fracasado."

Transformación:



"Estoy teniendo el pensamiento de que he fracasado."

Segunda transformación:

"Noto que mi mente está produciendo el pensamiento de que he fracasado."

El objetivo es aumentar distancia psicológica.

Debriefing

¿Qué ocurrió cuando dejaron de luchar contra el pensamiento?

¿Qué diferencia existe entre un pensamiento y una realidad?

ENCUENTRO 4

Derivación Responsable y Diseño de Redes

Ejercicio: La Conversación de Derivación

Fundamentación Académica

La derivación constituye una competencia ética fundamental. Reconocer los límites del acompañamiento pastoral protege tanto al líder como a la persona asistida.

Objetivos

Identificar señales de riesgo.

Comunicar límites profesionales.

Reducir estigma asociado a la salud mental.

Facilitar derivaciones efectivas.

Casos de Simulación

Caso 1

Ideación suicida activa.

Caso 2

Depresión severa persistente.

Caso 3



Ataques de pánico recurrentes.

Caso 4

Consumo problemático de sustancias.

Procedimiento

Paso 1: Validación

"Gracias por confiarme algo tan importante."

Paso 2: Reconocimiento del sufrimiento

"Entiendo que estás atravesando una situación muy difícil."

Paso 3: Establecimiento de límites

"Quiero acompañarte pastoralmente, pero esta situación requiere además apoyo especializado."

Paso 4: Derivación

"Me gustaría ayudarte a contactar un profesional capacitado que pueda brindarte la atención que necesitas."

Paso 5: Seguimiento

"¿Te parece si volvemos a conversar la próxima semana para acompañarte durante este proceso?"

Evaluación

Cada alumno es evaluado según:

Claridad del mensaje.

Empatía.

Ausencia de juicio.

Asertividad.

Capacidad para sostener la derivación frente a la resistencia.



TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Proyecto de Contención Psicológica Pastoral (PCPP)

Modalidad

Trabajo grupal institucional.

Extensión sugerida

20 a 30 páginas.

Rúbrica de Evaluación

1. Diagnóstico Comunitario (20 puntos)

Indicadores:

Relevancia.

Uso de datos.

Claridad descriptiva.

2. Protocolo de Escucha (20 puntos)

Indicadores:

Claridad operativa.

Factibilidad.

Consistencia.

3. Sistema de Triage (20 puntos)

Semáforo Verde

Crisis vitales esperables.

Conflictos interpersonales leves.

Necesidad de escucha.

Semáforo Amarillo

Ansiedad significativa.

Duelo complicado.



Estrés crónico.

Síntomas emocionales persistentes.

Semáforo Rojo

Riesgo suicida.

Autolesiones.

Psicosis.

Violencia grave.

Abuso de sustancias severo.

4. Red de Derivación (20 puntos)

Debe incluir:

Psicólogos clínicos.

Psiquiatras.

Hospitales.

Centros de emergencia.

Dispositivos comunitarios.

5. Plan de Autocuidado (20 puntos)

Debe contemplar:

Supervisión mensual.

Reuniones de descarga emocional.

Distribución equilibrada de casos.

Límites horarios ministeriales.

Prácticas personales de descanso y espiritualidad.

Criterio de Aprobación

El proyecto será aprobado cuando demuestre que la congregación posee un sistema organizado, ético y sostenible para brindar contención pastoral inicial,



reconocer situaciones de riesgo y facilitar el acceso oportuno a recursos profesionales de salud mental.

Para finalizar diremos que este programa no busca reemplazar la fe por la psicología, sino utilizar la ciencia psicológica como una herramienta complementaria que permite un ejercicio del ministerio más integral, ético y saludable.